

Malang, 01 Agustus 2026

Nomor : 378/I-PB/DIR/VIII/2026
Lampiran : 6 Halaman
Perihal : Pemberitahuan Hasil Audit Medis TKMKB Rujukan
Rawat Inap BPJS Kesehatan

Kepada Yth.

dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Direktur PT Disa Prima Medika
di tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari BPJS Kesehatan Nomor 4400/VII-05/0726 tentang Tindak Lanjut Audit Medis TKMKB Rujukan Rawat Inap, bersama ini kami sebagai berikut :

1. Disampaikan Laporan Kegiatan Audit Medis TKMKB Rujukan Rawat Inap sebagaimana terlampir. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi panduan dalam kendali mutu pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
2. Terhadap kasus yang tidak sesuai ketentuan, maka akan dilakukan kompensasi klaim.
3. Rincian berkas hasil audit :
 - 1) Total berkas yang diaudit : 101 berkas
 - 2) Total Klaim : 507.373.900
 - 3) Hasil Audit :
 - a. Berkas yang resleksi menjadi klaim Rawat jalan : 62 berkas
 - b. Total Tarif RS : 276.637.970
 - c. Biaya pengajuan INACBG'S (Awal) : 313.048.600
 - d. Resleksi : 40.404.600
 - 4) Total Pengembalian : 272.644.000

Demikian surat pemberitahuan dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M. Kes



Nomor : 4400/VII-05/0726

Malang, 21 Juli 2026

Lampiran : Dua berkas

Hal : Tindak Lanjut Audit Medis TKMKB
Rujukan Rawat Inap

Yth. Direktur RS Prima Husada
di
Malang

Pertama-tama kami manajemen BPJS Kesehatan Cabang Malang menyampaikan terimakasih atas dukungannya terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Menidaklanjuti Kegiatan Audit Medis TKMKB Rujukan Rawat Inap di RS Prima Husada tanggal 29 Juni 2026, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Disampaikan Laporan Kegiatan Audit Medis TKMKB Rujukan Rawat Inap sebagaimana terlampir. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi panduan dalam kendali mutu pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Terhadap kasus yang tidak sesuai ketentuan, maka akan dilakukan kompensasi klaim.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Cabang

^

Hernina Agustin Arifin

Tembusan: Kepala BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Malang
AN/de/pk00

Kantor Cabang Utama Malang

Jl. Raden Tumenggung Suryo 44 Malang
Telp. +62 341 493026
Fax. +62 341 493802
www.bpjs-kesehatan.go.id



TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA JKN TINGKAT CABANG MALANG

LAPORAN KEGIATAN AUDIT MEDIS TKMKB CABANG MALANG TAHUN 2026

I. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Jenis Kegiatan : Audit Medis Layanan Jaminan Kesehatan Nasional
- b. Pelaksana Kegiatan : 1. dr. Sasmojo Widito, Sp.JP(K), FIHA, FAsCC, FAPSIC, FSCAI
2. dr. Arry Budiarti
3. dr. Susanto Nugroho, Sp.A (K)
- c. Tanggal Kegiatan : 29 Juni 2026
- d. Tema Kegiatan : Evaluasi Rujukan Antar Rumah Sakit
- e. Lokus Audit : RS Prima Husada

II. Hasil Kegiatan

a. Temuan

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 93 kasus didapatkan 62 kasus tidak sesuai dengan temuan sebagai berikut:

1. Administratif

- Tidak terdapat catatan konsul dengan DPJP pada dokumen pengkajian awal UGD
- Indikasi dan tujuan rujuk tidak ditulis pada rekam medis (CPPT), resume medis, dan surat rujukan secara detail
- Pada pengkajian awal DPJP telah memberikan advise sudah pro rujuk
- Rumah sakit tujuan rujukan tidak sesuai dengan indikasi medis pasien yang dirujuk, misal membutuhkan pelayanan subspecialis neonatal, fasilitas stroke unit, atau membutuhkan tindakan spesialisik yang tidak tersedia pada RS tujuan rujukan
- Pasien yang dirujuk mendapatkan pelayanan yang sebenarnya tersedia di RS Prima Husada

2. Medis

- Pada pengkajian awal DPJP telah memberikan advise sudah pro rujuk
- Pasien belum mendapatkan visitasi DPJP selama di ruang rawat inap sampai dengan dirujuk, konsul pasien dilakukan melalui pesan instan atau telepon
- Pasien yang dirujuk mendapatkan pelayanan yang sebenarnya tersedia di RS Prima Husada
- Pasien telah mendapatkan perawatan di ruang *Intensive Care Unit* (ICU) dirujuk dengan indikasi membutuhkan fasilitas *stroke unit*
- Pasien STEMI atau NSTEMI dengan syok kardiogenik yang seharusnya segera dirujuk ke RS lain untuk tindakan PCI (*Percutaneous Coronary Intervention*), namun mendapatkan advise rawat inap
- Pasien dengan *Acute Coronary Syndrome* dirujuk dari RS Punten ke RS Prima Husada dengan DPJP yang sama. Demi keselamatan pasien (*patient safety*), pasien seharusnya langsung dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas *Cathlab*

b. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Untuk Manajemen RS

- Memastikan tersedianya PPK sesuai pedoman/ panduan/ guideline/ PNPK, sehingga bisa dipergunakan sebagai standarisasi layanan di RS Prima Husada. Termasuk disini adalah kriteria rujuk sesuai dengan kompetensi RS tujuan rujukan (mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana, tenaga medis, dan sarana penunjang)
- Melakukan perbaikan dan pembinaan terhadap seluruh jajaran tenaga medis maupun paramedis terkait temuan administratif dan medis termasuk ketertiban dalam penulisan rekam medis sesuai kaidah 3C yaitu clear, complete, dan correct
- Melakukan perbaikan pada sistem rekam medis agar :
 - 1) Konsul DPJP tercatat pada dokumen pengkajian awal UGD
 - 2) Indikasi dan tujuan rujuk tercantum secara detail pada rekam medis, resume medis dan surat rujukan.
- Melakukan utilization review mandiri dan audit medis mandiri atas data pelayanan rujukan ke RS lain setiap 3 bulan, membuat perencanaan tindakan korektif, dan monitoring efektivitas tindakan korektif.
- Mengoptimalkan Tim Pencegahan Kecurangan RS untuk berperan secara maksimal dan berintegritas dalam mencegah terjadinya potensi ketidaksesuaian
- Mempertimbangkan penyediaan sarana stroke unit karena stroke merupakan kasus terbanyak ke tiga rawat inap

2. Untuk DPJP

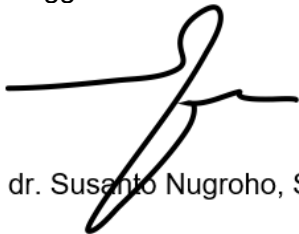
- Memberikan pelayanan sesuai indikasi yang benar berdasarkan pedoman klinis yang berlaku dan acuan terkini yang direkomendasikan
- Menuliskan rekam medis, resume medis dan surat rujukan secara lengkap dan benar, sesuai kaidah 3C yaitu clear, complete, dan correct

3. Untuk BPJS Kesehatan

- Meningkatkan kolaborasi dengan RS Prima Husada dalam memperbaiki kualitas layanan, klaim dan memberikan early warning kepada RS terkait data anomali dan bersama-sama menyelesaikan permasalahan dengan tujuan *patient safety*.
- Memberikan umpan balik utilization review rujukan antar RS setiap 6 bulan kepada FKRTL

Malang, 29 Juni 2026

Anggota TKMKB Cabang Malang



dr. Susanto Nugroho, Sp.A (K)

Ketua TKMKB Cabang Malang



dr. Sasmojo Widito, Sp.JP(K), FIHA,
FAsCC, FAPSIC, FSCAI

Sekretaris TKMKB Cabang Malang



dr. Arry Budiarti

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang



Hernina Agustin Arifin



TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA JKN TINGKAT CABANG MALANG

REKOMENDASI MEDIS HASIL AUDIT MEDIS EVALUASI RUJUKAN ANTAR RUMAH SAKIT BAGI PESERTA JKN DI RS PRIMA HUSADA

Berdasarkan hasil audit medis yang dilaksanakan pada hari Senin, Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam maka didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Temuan

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 93 kasus didapatkan 62 kasus tidak sesuai dengan temuan sebagai berikut:

1. Administratif

- Tidak terdapat catatan konsul dengan DPJP pada dokumen pengkajian awal UGD
- Indikasi dan tujuan rujuk tidak ditulis pada rekam medis (CPPT), resume medis, dan surat rujukan secara detail
- Pada pengkajian awal DPJP telah memberikan advise sudah pro rujuk
- Rumah sakit tujuan rujukan tidak sesuai dengan indikasi medis pasien yang dirujuk, misal membutuhkan pelayanan subspesialis neonatal, fasilitas stroke unit, atau membutuhkan tindakan spesialistik yang tidak tersedia pada RS tujuan rujukan
- Pasien yang dirujuk mendapatkan pelayanan yang sebenarnya tersedia di RS Prima Husada

2. Medis

- Pada pengkajian awal DPJP telah memberikan advise sudah pro rujuk
- Pasien belum mendapatkan visitasi DPJP selama di ruang rawat inap sampai dengan dirujuk, konsul pasien dilakukan melalui pesan instan atau telepon
- Pasien yang dirujuk mendapatkan pelayanan yang sebenarnya tersedia di RS Prima Husada
- Pasien telah mendapatkan perawatan di ruang Intensive Care Unit (ICU) dirujuk dengan indikasi membutuhkan fasilitas stroke unit
- Pasien STEMI atau NSTEMI dengan syok kardiogenik yang seharusnya segera dirujuk ke RS lain untuk tindakan PCI (Percutaneous Coronary Intervention), namun mendapatkan advise rawat inap
- Pasien dengan Acute Coronary Syndrome dirujuk dari RS Punten ke RS Prima Husada dengan DPJP yang sama. Demi keselamatan pasien (patient safety), pasien seharusnya langsung dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas Cathlab

b. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Untuk Manajemen RS

- Memastikan tersedianya PPK sesuai pedoman/ panduan/ guideline/ PNPK, sehingga bisa dipergunakan sebagai standarisasi layanan di RS Prima Husada. Termasuk disini adalah kriteria rujuk sesuai dengan kompetensi RS tujuan rujukan (mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana, tenaga medis, dan sarana penunjang)

- Melakukan perbaikan dan pembinaan terhadap seluruh jajaran tenaga medis maupun paramedis terkait temuan administratif dan medis termasuk ketertiban dalam penulisan rekam medis sesuai kaidah 3C yaitu clear, complete, dan correct
 - Melakukan perbaikan pada sistem rekam medis agar :
 - 1) Konsul DPJP tercatat pada dokumen pengkajian awal UGD
 - 2) Indikasi dan tujuan rujuk tercantum secara detail pada rekam medis, resume medis dan surat rujukan.
 - Melakukan utilization review mandiri dan audit medis mandiri atas data pelayanan ke RS lain setiap 3 bulan, membuat perencanaan tindakan korektif, dan monitoring efektivitas tindakan korektif.
 - Mengoptimalkan Tim Pencegahan Kecurangan RS untuk berperan secara maksimal dan berintegritas dalam mencegah terjadinya potensi ketidaksesuaian
 - Mempertimbangkan penyediaan sarana stroke unit karena stroke merupakan kasus terbanyak ke tiga rawat inap
2. Untuk DPJP
- Memberikan pelayanan sesuai indikasi yang benar berdasarkan pedoman klinis yang berlaku dan acuan terkini yang direkomendasikan
 - Menuliskan rekam medis, resume medis dan surat rujukan secara lengkap dan benar, sesuai kaidah 3C yaitu clear, complete, dan correct
3. Untuk BPJS Kesehatan
- Meningkatkan kolaborasi dengan RS Prima Husada dalam memperbaiki kualitas layanan, klaim dan memberikan early warning kepada RS terkait data anomali dan bersama-sama menyelesaikan permasalahan dengan tujuan *patient safety*.
 - Memberikan umpan balik utilization review rujukan antar RS setiap 6 bulan kepada FKRTL

Malang, 29 Juni 2026
Ketua TKMKB Cabang Malang



dr. Sasmojo Widito, Sp.JP(K), FIHA, FAsCC, FAPSIC, FSCAI